SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

Phân loại ưu tiên, nhận diện người bệnh nặng và theo dõi thời gian chờ

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVNT ngày / /2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân)

Mã: QĐ-A4.1 · Lần ban hành: 01

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Quy định việc phân loại ưu tiên người bệnh tại Khoa Khám bệnh, nhận diện và báo động sớm người bệnh nội trú diễn biến nặng, đo lường và cải tiến thời gian chờ. Quy trình cấp cứu, chỉ định nhập viện cấp cứu thực hiện theo Quyết định 79/QĐ-BYT và quy định của Khoa Cấp cứu.

Điều 2. Phân loại ưu tiên tại Khoa Khám bệnh

Mức	Người bệnh	Thời gian đích (mốc nội bộ)	Xử trí
Đỏ	Có dấu hiệu nguy hiểm (SOP-A4.1-01 mục 4)	Ngay	Chuyển Khoa Cấp cứu hoặc bác sĩ tiếp nhận ngay
Vàng	Không nguy hiểm tức thì nhưng cần khám sớm: đau nhiều, sốt cao ở trẻ nhỏ, người cao tuổi yếu, phụ nữ có thai có triệu chứng	≤ 30 phút	Xếp lượt ưu tiên, đo lại dấu hiệu sinh tồn khi chờ
Xanh	Ổn định	Theo thứ tự	Hướng dẫn đăng ký, chờ khám theo số

Đối tượng ưu tiên theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật nặng, người có công...) được xếp lượt ưu tiên trong cùng mức phân loại.

Điều 3. Nhận diện người bệnh nặng tại khoa nội trú

Điều dưỡng tính điểm cảnh báo sớm NEWS2 (BM-A4.1-03) mỗi lần đo dấu hiệu sinh tồn cho người bệnh người lớn, không áp dụng cho trẻ em và sản phụ (dùng công cụ riêng của Khoa Nhi, Khoa Phụ sản). Mức điểm quyết định tần suất theo dõi và thời gian báo bác sĩ theo SOP-A4.1-02. Điều dưỡng được quyền và có trách nhiệm báo bác sĩ bất cứ khi nào lo ngại về người bệnh, kể cả khi điểm thấp.

Điều 4. Đo thời gian chờ

Mốc	Định nghĩa	Cách đo
Chờ đăng ký	Lấy số đến đăng ký xong	Phần mềm gọi số hoặc BM-A4.1-01

Mốc	Định nghĩa	Cách đo
Chờ khám	Đăng ký xong đến bác sĩ khám	BM-A4.1-01, ghi giờ trên phiếu
Chờ cận lâm sàng	Có chỉ định đến có kết quả (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh thường quy)	Giờ chỉ định, giờ kết quả trên HIS
Chờ nhập viện	Ký chỉ định nhập viện đến khi khoa nhận người bệnh	Giờ trên giấy nhập viện và phiếu bàn giao
Chờ nhận thuốc	Thanh toán xong đến nhận thuốc	BM-A4.1-01 (năm 2024 đo được 18 phút)

Cỡ mẫu: tối thiểu 30 người bệnh/tháng, chọn ngẫu nhiên ở 3 khung giờ (sáng sớm, giữa buổi sáng, chiều). Báo cáo trung vị và tỷ lệ vượt thời gian đích.

Chương II. GIÁM SÁT, CẢI TIẾN, TRÁCH NHIỆM

Điều 5. Giám sát và cải tiến

- Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh: giám sát phân loại 10 lượt/tháng; điều dưỡng trưởng khoa nội trú: kiểm tra 05 hồ sơ có NEWS2 ≥ 5/tháng (BM-A4.1-04).
- Phòng Điều dưỡng tổng hợp chỉ số hằng tháng; phân tích nguyên nhân khi thời gian chờ tăng hoặc có sự cố chậm xử trí (SOP-A4.2-02).
- Phòng QLCL, Phòng KHTH: phân tích quá tải, đề xuất cải tiến (tăng quầy, tăng ca kỹ thuật viên giờ cao điểm, đặt khám trước, quản lý giường).

Điều 6. Trách nhiệm

- Phòng Điều dưỡng: đào tạo phân loại, NEWS2; giám sát; tổng hợp chỉ số A4.1 phần điều dưỡng.
- Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu: tổ chức phân loại, luồng ưu tiên, chuyển cấp cứu.
- Các khoa nội trú: áp dụng NEWS2, báo động sớm, nhận người bệnh nhập viện kịp thời.
- Khoa cận lâm sàng: bảo đảm thời gian trả kết quả; báo ngay kết quả nguy hiểm.
- Phòng KHTH, Phòng QLCL: theo dõi thời gian chờ toàn viện, điều phối giường, cải tiến.

Điều 7. Hiệu lực

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

GIÁM ĐỐC